Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Capão da Canoa

Avenida Central, 1981, 5º andar - Bairro: Zona Nova - CEP: 95555000 - Fone: (51)3098-5390 - Balcão Virtual: (51) 99573-5566 - Email: frcapcanoa2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005910-86.2024.8.21.0141/RS

AUTOR: GESSI DA COSTA CASSEL DE MOURA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

GESSI DA COSTA CASSEL DE MOURA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer contra o **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPÊ-SAÚDE**. Alegou a parte autora, em síntese, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do quadrante inferior interno da mama (CID C50.3), lhe sendo prescrito pelo médico responsável o tratamento medicamentoso com o Trastuzumabe Deruxtecan 540mg, conforme protocolo detalhado. Disse que é segurada do Instituto requerido e, ao buscar o fornecimento do tratamento, este foi inviabilizado, pois "o medicamento não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia do IPÊ-SAÚDE". Assim, diante da necessidade de iniciar o tratamento, não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação, diante da falta de recursos para aquisição do medicamento de forma particular. Requereu a concessão de tutela de urgência. No mérito, a confirmação da tutela para ver garantido o fornecimento do medicamento para o tratamento postulado na inicial, bem como a concessão da gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária à autora, bem como concedida a tutela de urgência (evento 3, DESPADEC1).

A parte requerida compareceu aos autos e comprovou o cumprimento da liminar (evento 9, OFIC1).

Ofertada contestação pelo réu **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPÊ-SAÚDE**. Em suas razões, discorreu sobre a natureza de autogestão do plano e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu que sua cobertura é adstrita às normativas próprias, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e desequilíbrio financeiro-atuarial. Aduziu que não há previsão de fornecimento do medicamento postulado na inicial para a patologia da autora em seus protocolos. Postulou a revogação da tutela concedida, com a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (evento 14, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 17, RÉPLICA1).

Intimadas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela procedência da ação (evento 28, PARECER1).

Foi encerrada a instrução processual (evento 31, DESPADEC1).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

O feito tramitou regularmente, não existindo questões prejudiciais ou preliminares ao mérito que se imponha o enfrentamento, estando apto ao julgamento, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.

Cuida-se de ação em que busca a parte autora fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan 540mg, prescrito pelo médico responsável, para tratamento de sua patologia - neoplasia maligna do quadrante inferior interno da mama (CID C50.3), afirmando negativa ao fornecimento do medicamento pelo Instituto réu na via administrativa.

Pois bem.

No caso, demonstrou a parte autora ser segurada do Instituto réu, conforme documentos anexados à inicial.

Quanto ao fornecimento do medicamento postulado na inicial, ressalto que em 05 de abril de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, legislação que aplicável ao caso em análise.

Referida legislação dispõe sobre o IPE-Saúde, disciplinando que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, *in verbis*:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

Todavia, em que pese as disposições da nova lei, inclusive quanto as exclusões da cobertura do plano de saúde de tratamentos não previsto, entendo que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado.

Cabe destacar, ainda, que a Resolução nº 21/1979, que regulamenta a assistência Médico-Hospitalar do IPERGS, assim dispõe:

Artº 2º - O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.

§ Primeiro – O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.

§ Segundo – O Plano será fundamental baseado nos seguintes princípios:

a) co-participação financeira do usuário.

b) livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciadas.

Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades:

Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia.

(...)

Artº 9º - A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:

1 – Emergências

2 – Consultas Médicas

3 – Serviços Complementares

4 – Tratamento Ambulatorial

5 – Tratamento Hospitalar

Desta feita, é caso de fornecimento pelo plano de saúde o tratamento de oncologia postulado, pois comprovada a enfermidade que acomete a autora e a necessidade da medicação.

Ademais, deve o plano de saúde cobrir o medicamento requerido, sem selecionar o tipo de tratamento médico que será coberto, pois a escolha do tratamento cabe ao médico e não ao convênio.

Nesse sentido, cito os precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DE COBERTURA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. CASO EM EXAME: Ação de obrigação de fazer ajuizada por usuária do plano de saúde de autogestão estadual visando ao fornecimento do medicamento Daratumumabe 400mg/frasco, para tratamento de mieloma múltiplo, doença grave em estágio avançado. A cobertura do tratamento foi negada administrativamente pelo ente gestor do plano, sob alegação de ausência de previsão no protocolo oncológico e nas tabelas do instituto. Sentença de procedência. Apelação interposta pelo réu. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: I. Possibilidade de recusa, pelo plano de saúde de autogestão, da cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer, com fundamento na ausência de previsão nas tabelas e protocolos internos; II. Cabimento da fixação de honorários sucumbenciais por equidade em demandas relativas ao direito à saúde, quando vencida a Fazenda Pública. 3. RAZÕES DE DECIDIR: A recusa administrativa de cobertura para medicamento oncológico, ainda que não incluído nas tabelas internas ou protocolos da autarquia gestora do plano de saúde, revela-se indevida, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a negativa de tratamento prescrito por profissional habilitado é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Ademais, a própria legislação estadual de regência do IPE Saúde contempla, em seu art. 4º, a cobertura de atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento. Em relação aos honorários, apesar da fixação ordinária com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, é admissível a fixação por equidade, conforme § 8º do mesmo artigo, nas causas de valor inestimável que envolvam o direito à saúde, inclusive quando vencida a autarquia ré, conforme interpretação pacificada no Tema 1076/STJ. Na hipótese, o valor arbitrado na origem mostrou-se excessivo frente à baixa complexidade jurídica da demanda e ao tempo de tramitação, comportando redução. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, fica mantida a decisão recorrida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50010971920248210043, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 24-07-2025)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO. DIREITO EVIDENCIADO. 1. O médico que assiste a parte autora informou que a mesma está fazendo tratamento para dor oncológica, apresentando diagnóstico de Neoplasia de mama desde 2012. Apresenta surgimento de metástase óssea com dor neuropática e nociceptiva por compressão de nervo. O médico sustenta que a parte autora necessita de uso contínuo dos medicamentos pleiteados para tratamento da dor. 2. A Lei Complementar nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79 estabelecem que o Plano IPE-SAÚDE abrange os atendimentos médicos, hospitalares, materiais relacionados e atos necessários ao tratamento, bem como ações de prevenção de doença e de promoção à saúde. 3. No caso concreto, o fármaco requerido pela parte autora para fins de tratamento oncológico não tem vedação expressa do seu custeio. 4. Assim sendo, a ausência de previsão do medicamento no Protocolo Oncológico do Instituto não exclui o direito da autora ao tratamento prescrito pelo médico assistente como sendo o mais

adequado ao seu caso. 5. Sentença de improcedência reformada para julgar procedente a demana e condenar o Réu ao fornecimento dos medicamentos Pregabalina 150mg e Matadona 10mg. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50680968520218210001, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 19-06-2023)

O pedido da parte autora está devidamente amparado por laudo médico evento 1, ATESTMED7), que atesta a gravidade da doença e a adequação do tratamento prescrito.

PACIENTE
Gessi da Costa Cassel de Moura
CPF: 702.676.340-72

RELATÓRIO MÉDICO

Declaro, a pedido e sob autorização da paciente supracitada, que a mesma é acometida por Neoplasia de Mama Metastática, já tendo realizado duas linha de tratamento paliativo. No momento a paciente vem com progressão em Sistema Nervoso Central (cérebro), estando em uso de Trastuzumab-Entansina.
Declaro que a paciente, que inicialmente tratou a doença na cidade de Santo Angelo, com mastectomia seguida de tratamento adjuvante com Trastuzumab isolado, no ano de 2020, progrediu no ano de 2022 com implante isolado em SNC (cérebro) e realizou ressecção e radioterapia, sem tratamento sistêmico complementar. Novamente no ano de 2022 a paciente progrediu com aumento da lesão previamente ressecada e novamente foi levada a cirurgia.
Nesse momento a paciente foi levada a tratamento sistêmico com duplo bloqueio do eixo HER-2 com Pertuzumab e Trastuzumab isolados (sem quimioterapia). Após conseguir manter tratamento entre os meses de Fev/23 e Ago/23 a paciente apresenta nova progressão da mesma lesão citada e então passa a fazer uso de Trastuzumab-Entansina, do qual faz uso entre os meses de Out/23 até o mês atual de Fev/24.
No momento a pacienete se apresenta com surgimento de ao menos 4 novas lesões em SNC (cérebro) e com perda de força em hemilado direito com boa resposta no uso de corticóide e com plano breve de realizar radiocirurgia das lesões que surgiram.
Possuindo em neoplasia Maligna de Mama Metastática com perfil de resposta HEr-2 a paciente passa a apresentar poucas opções de tratamento e nenhuma opção de tratamento pelo Manual de Recomendações da instituição que zela por sua Saúde. No entanto, o uso de Trastuzumab-Deruxtecan é perfeitamente aplicável para o tratamento de sua comorbidade e apresenta inclusiva excelente resposta clínica, podendo ser usado em primeira linha, conforme determinação da ANS. Reforço também que a medicação indicada é a melhor opção para o tratamento de paciente com implantes (metastases) em SNC. Declaro que conforme estudos, deixo abaixo acesso na internet do mesmo, o uso da medicação preconizada oferece a paciente melhora da qualidade de vida e, principalmente, aumento do tempo de vida.

CID10 C50.3

Estudo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2115022

04 de Março de 2024

Veja-se que o laudo trouxe toda a evolução clínica da paciente, ora autora, bem como tratamentos e procedimentos cirúrgicos pretéritos.

Igualmente, trouxe estudo existente indicando o medicamento para tratamento da doença da Autora, como primeira linha de tratamento indicado, considerando o quadro clínico da paciente.

Assim, a negativa de fornecimento administrativa se mostrou indevida, sendo conclusão dos autos a procedência do pedido autoral.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTE** os pedidos formulados por **GESSI DA COSTA CASSEL DE MOURA** contra o **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPÊ-SAÚDE** para o efeito de tornar definitiva a liminar concedida no evento 3, DESPADEC1 e **CONDENAR** o requerido ao fornecimento à autora do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecan 540mg**, nos termos da prescrição médica e enquanto houver laudo médico determinando a sua prescrição, sob pena de bloqueio de valores para a aquisição de forma particular pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 111.735,00), atualizado pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos do art. 85, §2º e incisos do CPC.

Isento a Demandada do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Caso a parte vencedora tenha antecipado taxa única e despesas, o ente público deverá reembolsar estes valores da seguinte forma (Lei n° 14.634/2014, art. 5º, parágrafo único, parte final):

a) com correção pelo IPCA-E (admitida a deflação, preservado o valor nominal, conforme o Tema n° 678 do STJ) a contar da data de cada desembolso;

b) com juros moratórios à taxa aplicada à caderneta de poupança (art. 12, inc. II da Lei Federal n° 8.177/1991), a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Em havendo interposição de eventual(is) recurso(s), independentemente de conclusão, intime(m)-se o(s) apelado(s) para oferecer(m) contrarrazões, remetendo-se posteriormente o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do RS, consoante artigo 1.010, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Sentença publicada, registrada e partes intimadas eletronicamente.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, proceda-se a baixa definitiva.

Dil. Legais.

Documento assinado eletronicamente por **AMITA ANTONIA LEAO BARCELLOS MILLETO, Juíza de Direito**, em 03/11/2025, às 18:58:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10094490608v10** e o código CRC **668b7d42**.